10. 心臓：動脈解剖の発生

所要時間：04:14　学習シート

コース概要

このビデオは、血液細胞の胚発生の中心に深く入り込み、臍帯小胞から骨髄までの起源を記述しています。また、このプロセスの重要な痕跡である腸間膜動脈の持続性と、それが腸の発達に果たす役割も探求しています。大動脈弓は、心臓のリズミカルな動きとそれが血液循環に与える影響を説明するために強調されています。心臓のダイナミクスと、食道や気管支などの重要な構造を維持する筋膜環境を関連付けることで、このリズミカルな領域の不均衡が心臓病や筋骨格系の病状にどのように影響するかをビデオは明らかにしています。身体の相互接続に関心のあるすべてのセラピストにとって不可欠な教訓です。

心臓：動脈解剖学の発生

血液細胞の起源と発生

最初の**血液細胞**は、胚発生の**18日目**頃に出現します。その起源は3つの重要な段階に分けられます。

最初に、それらは**臍帯嚢**から生じ、そこには**原始巨赤芽球**が見られます。この段階は最初の2ヶ月間続きます。

2ヶ月目の初めには、**肝臓**から2番目の血液産生運動が出現します。

3ヶ月目頃になって初めて、この産生の一部が**骨髄**で行われるようになります。

ここでは、末梢から中心への発生が見られます。まず**臍帯-卵黄嚢期**、次に**肝臓期**、そして最後に**赤血球**のための骨髄です。

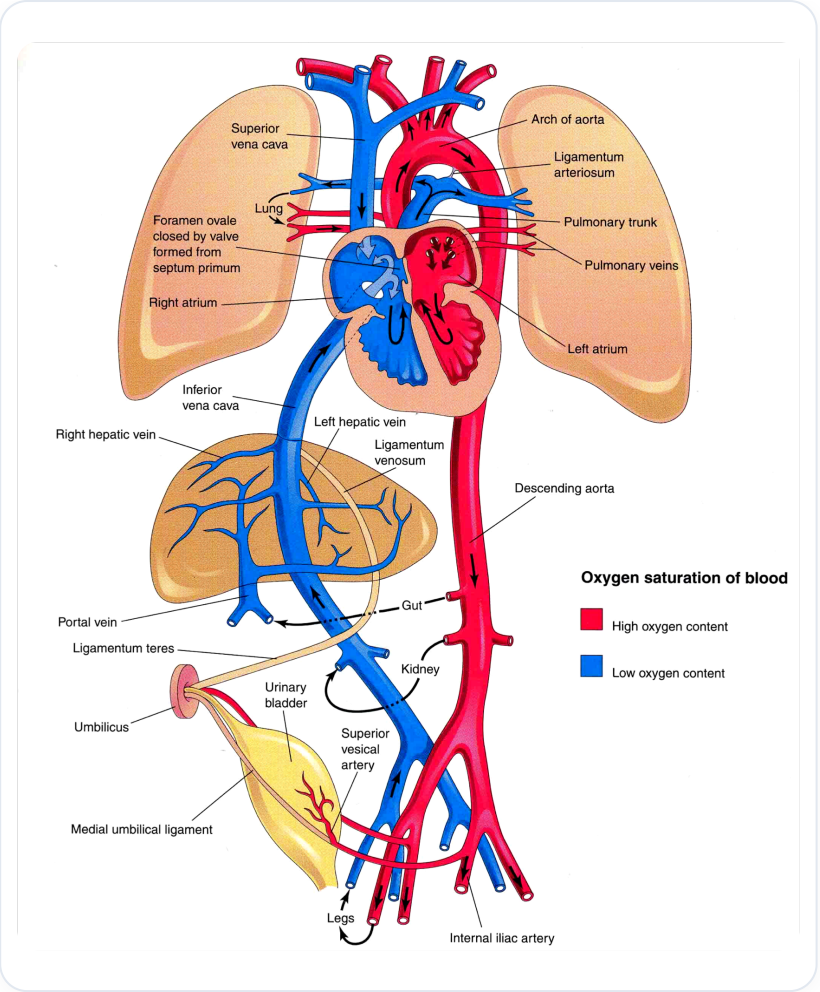
卵黄発生の痕跡：腸間膜動脈

この卵黄発生から残る唯一の痕跡は、**腸間膜動脈**です。

それは、**腸管ループ**の回転と発生のための回転軸、つまり**支点**として機能していました。

羊膜腔が周囲に形成されると、循環のための元の細胞を含む卵黄嚢が再統合されます。

一部は、卵黄嚢とともに、**胚柄**が胎盤とともに**臍帯結腸**を形成します。連結される痕跡は**腸間膜系**（上腸間膜動脈）です。この回転軸は胚発生にとって極めて重要です。



図— ヒトの胎児循環

心臓と大動脈弓の動き

心臓を観察すると、**大動脈弓**が見えます。象徴的に言えば、それは上昇したり下降したりすると言えます。

この大動脈弓の動きは、**心臓の拍動**を表しています。それはほとんど発生的な動きを再現しています。

大動脈弓は、心周期中に**ねじれ**または**ねじれ解除**の動きを行います。

心臓が収縮するとき、大動脈弓は開いて血液を吸収します。心臓が空になるとき、それは特定の動きをして閉じます。

それは血液を取り込むために開き、排出するために閉じます。これは大動脈弓と心臓の機能を本質的に結びつけています。

大動脈弓と心周期

それはまるで**バスケットボール**選手のようなものです。心臓が上昇するとき、大動脈が血液を排出します。

大動脈は、動脈系において心臓とほぼ同じ量の血液を含んでいることを知っておく必要があります。

これは、大動脈が血液の**収縮期駆出**に積極的に関与していることを意味します。

これは、**「フィッシュネットストッキング」**（網タイツ）に例えられる**筋膜環境**によって支えられています。

リズミカルゾーン：重要な筋膜の交差点

大動脈弓、**気管支分岐部**、および**食道**は、共通の**筋膜**によって連結されており、それらをまとめています。

気管支分岐部によって特徴づけられるこの領域は、**リズミカルゾーンのポイント**と呼ばれます。

生命のリズムを考えてみてください。24時間で**10万回の心拍**、24時間で**2万3千回の呼吸**、そして**1千から2千回の嚥下**です。

これは、**D3**、**D4**、および**D5**の間で合流し、付着する大きなリズミカルゾーンです。これらの椎骨は、**心臓**、**胸膜**、および**消化器**のすべてにわたるリズミカルゾーンの筋膜の平衡面を形成します。

大動脈、心臓があり、下には非常に重要な分岐点である**腸骨動脈**があります。上にはさらに別のレベルがあります。

実際、これらすべてが統一された純粋な平面を形成しています。**股関節**などの特定の病状が心臓を不安定にすることがあります。逆に、これらの回転段階で起こることは、心臓のレベルまで現れる可能性があります。

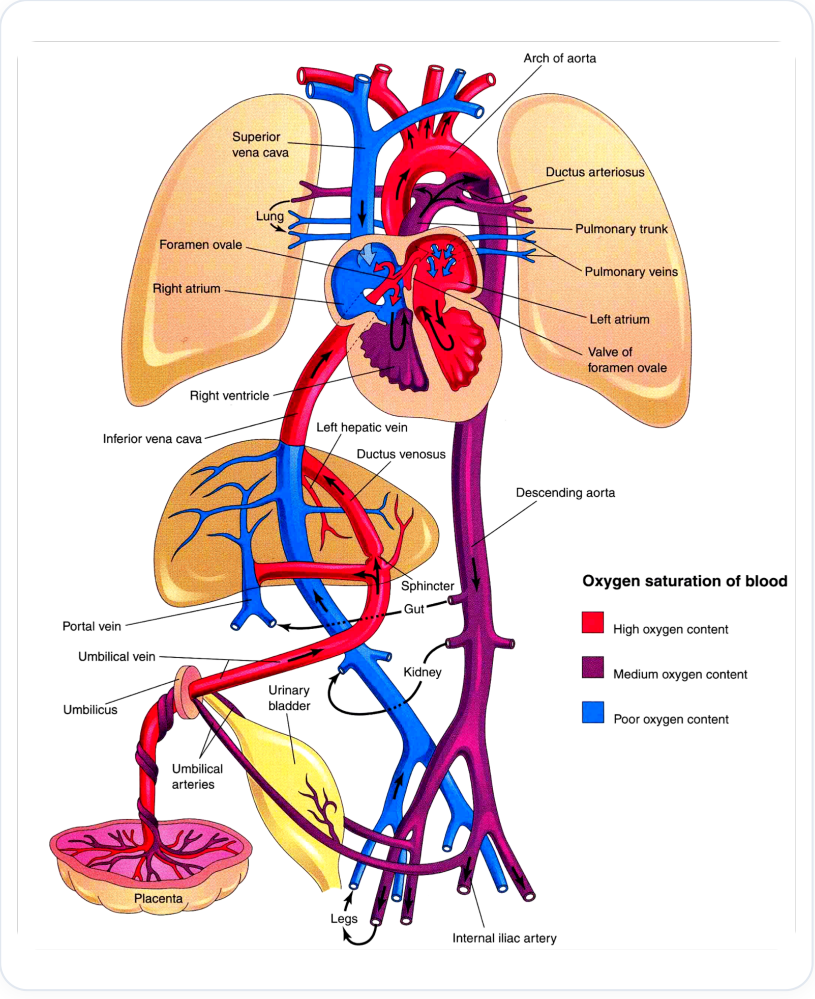


図 — 胎児循環